PROTOCOLLO 66

Autoallungamento in apertura

Mantenere e aumentare il range di apertura a domicilio

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, artralgia, disturbi del controllo	5 a 10 minuti	Ogni giorno a domicilio

Indicazioni

- ✓ Ipomobilità muscolare
- ✓ Mantenimento dei risultati
- ✓ Rigidità mattutina

Controindicazioni e precauzioni

- ! Dolore acuto in rapido aumento
- ! Lussazione recente o blocco in apertura non risolto
- ! Chirurgia recente senza indicazioni del chirurgo
- ! Esercizio che riproduce un click doloroso: modificarlo

Posizionamento

Paziente: seduto davanti a uno specchio, schiena appoggiata.

Fisioterapista: di fronte al paziente per insegnare e correggere.

Esecuzione passo dopo passo



Riscaldamento
Calore umido o aperture lente.



Presa
Dita sugli incisivi inferiori.



Allungamento
Apri fino a una tensione confortevole e mantieni.



Respirazione
Respira lentamente durante la tenuta.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Tenuta	30 secondi
Ripetizioni	3
Frequenza	2 volte al giorno

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Tensione, mai dolore
- ✓ Associa la respirazione
- ✓ Misura l'apertura ogni settimana

Errori da evitare

- ! Rimbalzi
- ! Allungare con dolore preauricolare
- ! Spingere sugli incisivi superiori

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autoallungamento	Apertura assistita con le dita mantenuta	3 x 30 secondi, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Se compare dolore articolare durante l'allungamento, riduci l'ampiezza e rivaluta.

Bibliografia essenziale

1. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.
2. List T., Jensen R.H. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. 2017;37(7):692–704.